

切除不能局所進行非小細胞肺癌

51 ~ 54

- 51★★★
☑☑☑ 切除不能Ⅲ期では化学放射線療法施行後、デュルバルマブの維持療法を2年行うことが推奨される。
- 52★★★
☑☑☑ デュルバルマブ投与中に肺障害の有害事象を発症した場合、その重症度に関係なく投薬を中止する。
- 53★★★
☑☑☑ 化学療法と同時併用の放射線療法の場合、V20が50%以下であれば肺障害のリスクが低い。
- 54★★★
☑☑☑ 強度変調放射線治療 (intensity modulated radiation therapy: IMRT) は腫瘍やリスク臓器の形状に合わせた複雑な線量分布を作成できる高精度の放射線治療である。

非小細胞肺癌手術症例

55 ~ 63

- 55★★★
☑☑☑ ⅢA期では、N0-1であれば外科的切除が推奨される。
- 56★★★
☑☑☑ ⅢA期においてN2が疑われる場合は、組織学的診断が推奨される。
- 57★★★
☑☑☑ T3N0-1の胸壁もしくは心膜浸潤例では外科的切除は推奨されない。
- 58★★★
☑☑☑ 肺尖部胸壁浸潤癌においては術後化学療法が推奨される。
- 59★★★
☑☑☑ EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌病理病期Ⅱ-ⅢA期では術後EGFR-TKIによる補助化学療法が推奨される。
- 60★★★
☑☑☑ 病変全体径1 cm以上の非小細胞肺癌ⅠA-B/ⅡAの完全切除例では術後UFT (テガフル・ウラシル) の内服が推奨される。
- 61★★★
☑☑☑ ⅠA期で最大腫瘍径2 cm以下であれば縮小手術 (区域切除または楔状切除) を検討してもよい。
- 62★★★
☑☑☑ 肺癌の根治手術後も禁煙が推奨されている。
- 63★★★
☑☑☑ カルチノイド、腺様嚢胞癌、粘表皮癌のような低悪性度腫瘍では、手術は推奨されない。

